Hồ sơ thực hiện tiêu chí A4.1

Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

Dự thảo trình duyệt năm 2026. Bộ hồ sơ cung cấp ma trận yêu cầu, quy định triển khai đề xuất, kế hoạch, chỉ số và biểu mẫu để các đơn vị bổ sung minh chứng thực tế. Chưa có căn cứ kết luận mức đạt của bệnh viện.

Số văn bản và phiên bản .....

Ngày phê duyệt và áp dụng .....

Người soạn thảo .....

Người rà soát .....

Người phê duyệt .....

Đầu mối và cách sử dụng

Phòng Kế hoạch tổng hợp và các khoa lâm sàng phối hợp Phòng Điều dưỡng, tài chính, dược, bộ phận BHYT và QLCL. Đây là phân công đề xuất, phải xác nhận với cơ cấu và thẩm quyền thực tế trước ký.

Không ghi lùi ngày, tạo chữ ký hoặc điền số liệu thay cho hoạt động chưa thực hiện. Mã biểu mẫu là mã đề xuất, cần thống nhất với quản lý tài liệu bệnh viện. Hồ sơ tiêu chí quản lý không bị ép theo đề cương quy trình kỹ thuật QĐ3023.

1 Căn cứ và nguyên tắc đối chiếu

Căn cứ trực tiếp: QĐ6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, A4.1, trang in 33–34 [1]. Ma trận sau diễn giải rút gọn, giữ số mục và mức để tra cứu cùng bản gốc.

Bộ phận QLCL và pháp chế đối chiếu thêm hướng dẫn kiểm tra của kỳ đánh giá thực tế; không mặc định mọi viện dẫn trong phần căn cứ lịch sử năm 2016 còn hiện hành. Các nội dung quyền người bệnh thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 và văn bản liên quan hiện hành.

Kiểm tra tình trạng bất lợi mức 1 trước. Khi có tình trạng mức 1, xử lý và đánh giá theo hướng dẫn của Bộ tiêu chí; không biến tình trạng đó thành yêu cầu tích cực. Nếu không có tình trạng mức 1, đối chiếu tích lũy mức 2–5, không lấy trung bình số ô đáp ứng để xếp mức.

Phiếu tóm tắt thông tin điều trị là tài liệu cho một bệnh xác định, khoảng một đến hai trang hoặc tờ rơi; rút từ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cần diễn đạt dễ hiểu và cho người bệnh tự đánh dấu theo dõi việc đã làm hoặc dự kiến làm.

Tờ rơi giáo dục sức khỏe chung không tự thay thế phiếu tóm tắt điều trị theo bệnh. Khung BM02 trong hồ sơ này phải được từng khoa điền nội dung theo bệnh và phê duyệt trước khi tính vào tỷ lệ 50% hoặc năm bệnh mỗi khoa.

Điều dưỡng phối hợp cung cấp thông tin trong phạm vi nhiệm vụ; bác sĩ hoặc người hành nghề có trách nhiệm giải thích nội dung chẩn đoán và lựa chọn điều trị chuyên sâu. Cam kết chung lúc nhập viện không thay mọi chấp thuận cụ thể.

2 Ma trận tiểu mục 1 đến 10

Mục mức	Nội dung đối chiếu	Minh chứng cần có
1 M1	Có người bệnh không được thông tin tình hình bệnh, chẩn đoán và dự kiến điều trị khi nhập viện	Phỏng vấn, hồ sơ và xác minh phản ánh.
2 M2	Có nội quy, hướng dẫn dễ nhìn ở sảnh, phòng chờ và khoa	Bản được duyệt và kiểm tra vị trí.
3 M2	Thông tin chẩn đoán, nguy cơ, tiên lượng, dự kiến phương pháp và thời gian điều trị khi nhập viện	Ghi nhận giải thích của người có trách nhiệm.
4 M2	Giải thích tình trạng, kết quả, rủi ro để người bệnh lựa chọn phương pháp	Hồ sơ trao đổi, phương án và lựa chọn.
5 M2	Giải thích rõ thủ thuật, phẫu thuật trước thực hiện	Phiếu tư vấn, cam kết và phỏng vấn.
6 M2	Thông tin tính chất, giá và lựa chọn thuốc, vật tư trước sử dụng dịch vụ	Thông tin đã giải thích và nguồn giá chính thức.
7 M2	Giải đáp thắc mắc trước ký cam đoan, cam kết	Ghi câu hỏi, trả lời và xác nhận hợp lệ.
8 M2	Thông báo được lựa chọn vào nghiên cứu và quyền chấp nhận hoặc từ chối nếu có	Hồ sơ nghiên cứu và chấp thuận phù hợp.
9 M3	Thông tin giá dịch vụ, kỹ thuật cao, chi phí lớn	Bảng giá hiện hành và bằng chứng cung cấp.
10 M3	Giải thích trực tiếp phạm vi BHYT chi trả thuốc, vật tư khi có thắc mắc	Ghi tư vấn và đối chiếu quyền lợi thực tế.

Kết quả từng dòng: ghi tại phiếu tự đánh giá cuối hồ sơ. Dẫn mã minh chứng và vị trí tra cứu; quan sát một thời điểm không thay thế yêu cầu theo dõi cả năm khi tiêu chí có quy định.

2 Ma trận tiểu mục 11 đến 20

Mục mức	Nội dung đối chiếu	Minh chứng cần có
11 M3	Giải thích khoản chi trên hóa đơn khi có thắc mắc	Sổ tiếp nhận và trả lời.
12 M3	Công khai số lượng thuốc, vật tư dùng hằng ngày	Bảng kê và xác nhận theo quy định.
13 M3	Cung cấp chi phí điều trị hằng ngày hoặc khi có yêu cầu	Bảng kê và lịch sử cung cấp.
14 M3	Cung cấp thông tin tóm tắt hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu	Yêu cầu, xác minh và bằng chứng trả kết quả.
15 M4	Ít nhất 50% khoa lâm sàng xây dựng phiếu tóm tắt cho một bệnh thường gặp	Danh sách đầy đủ khoa; phiếu đúng bệnh, nguồn và phê duyệt.
16 M4	In, phát và tư vấn phiếu để người bệnh cùng theo dõi điều trị	Phiếu đã cấp và ghi nhận tư vấn.
17 M5	Mỗi khoa lâm sàng có phiếu tóm tắt cho ít nhất năm bệnh thường gặp	Danh mục theo từng khoa và bản phiếu.
18 M5	Rà soát phiếu định kỳ một hoặc hai năm, hoặc khi hướng dẫn thay đổi	Lịch, biên bản và lịch sử phiên bản.
19 M5	Có nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng phiếu	Đề cương, dữ liệu, báo cáo.
20 M5	Áp dụng kết quả nghiên cứu để cải tiến điều trị	Kế hoạch, triển khai và đánh giá lại.

Kết quả từng dòng: ghi tại phiếu tự đánh giá cuối hồ sơ. Dẫn mã minh chứng và vị trí tra cứu; quan sát một thời điểm không thay thế yêu cầu theo dõi cả năm khi tiêu chí có quy định.

3 Quy định triển khai đề xuất

Mục tiêu: Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị. Phạm vi bao gồm các đơn vị liên quan trực tiếp và bộ phận hỗ trợ. Ban Giám đốc phê duyệt quy định, nguồn lực và phân cấp; trưởng đơn vị tổ chức thực hiện, giám sát và xử lý phát sinh; QLCL tổng hợp kết quả và theo dõi cải tiến.

Xác định người nhận thông tin

Xác minh người bệnh, khả năng tiếp nhận, ngôn ngữ, người đại diện hợp lệ và phạm vi được chia sẻ. Người nhà không mặc nhiên thay người bệnh có khả năng tự quyết định.

Giải thích và hỗ trợ quyết định

Giải thích tình trạng, lựa chọn phù hợp, lợi ích, nguy cơ, lựa chọn khác và hậu quả khi không thực hiện trong phạm vi chuyên môn. Dùng từ dễ hiểu, hỗ trợ phiên dịch khi cần, để người bệnh hỏi và kiểm tra hiểu bằng nhắc lại.

Thông tin chi phí và quyền lợi

Cung cấp giá và dự kiến chi phí từ nguồn đã được duyệt, phân biệt dự kiến với thực tế. Giải thích BHYT theo quyền lợi, điều kiện chi trả và dịch vụ cụ thể; không tự hứa được thanh toán. Chuyển câu hỏi đến tài chính/BHYT khi vượt phạm vi.

4 Xử lý tình huống và kiểm soát thực hiện

Ghi nhận lựa chọn và chấp thuận

Lưu nội dung đã giải thích, câu hỏi, quyết định, người giải thích, thời điểm và xác nhận theo biểu mẫu có thẩm quyền. Tôn trọng quyền từ chối theo luật; xử lý cấp cứu, bắt buộc chữa bệnh, người chưa thành niên hoặc không thể quyết định theo quy định pháp luật, không áp dụng máy móc mẫu chung.

Theo dõi và cung cấp bản tóm tắt

Cập nhật khi kế hoạch thay đổi, công khai thuốc/vật tư và chi phí theo quy định. Tiếp nhận yêu cầu tóm tắt hồ sơ, xác minh quyền tiếp cận, chuyển đầu mối lưu trữ, trả đúng người và lưu dấu vết; không phát toàn bộ hồ sơ tùy tiện.

Ghi nhận và kiểm soát minh chứng

Ghi đúng thời điểm, người thực hiện, kết quả và việc chưa hoàn thành. Phân quyền truy cập, dùng mã thay dữ liệu định danh trong báo cáo tổng hợp; giữ hồ sơ chi tiết ở nơi được phép. Chứng cứ ảnh phải có bối cảnh, thời gian và mục đích phù hợp, không công khai thông tin người bệnh trái quy định.

Tài liệu và bảng nhắc cần được rà soát chuyên môn, phê duyệt đúng thẩm quyền, cấp phiên bản và phổ biến. Khi thay đổi phải thu hồi bản cũ và hướng dẫn lại. Đào tạo có nội dung, danh sách tham dự thật, kiểm tra khả năng thực hiện và kế hoạch học bù.

5 Kế hoạch triển khai và đo lường

T0 là ngày phê duyệt thực tế. Lịch dưới đây là đề xuất để đơn vị điều chỉnh theo nguồn lực; không phải lịch bắt buộc do Bộ tiêu chí ấn định.

Thời hạn	Công việc	Sản phẩm
T0 + 15 ngày	Khảo sát từng tiểu mục, xác định khoảng thiếu.	Dữ liệu nền và phân công.
T0 + 30 ngày	Trình quy định, công cụ, nguồn lực và đào tạo.	Văn bản được duyệt và hồ sơ phổ biến.
T0 + 60 ngày	Triển khai, kiểm tra thực hành, ghi dữ liệu.	Biểu mẫu thực tế và xử lý tồn tại.
T0 + 90 ngày	Đánh giá, phản hồi, cải tiến và đo lại.	Báo cáo và hành động theo dõi.

Khoa có ít nhất một phiếu theo bệnh

Số khoa lâm sàng có ít nhất một phiếu phù hợp đã được duyệt / tổng khoa lâm sàng thuộc phạm vi đánh giá × 100%. Ngưỡng mức 4 là ≥50%; phải kiểm tra sử dụng thực tế ở tiểu mục 16.

Khoa có ít nhất năm phiếu theo bệnh

Theo dõi số phiếu đúng bệnh ở từng khoa, không dùng tổng toàn viện chia bình quân. Mức 5 yêu cầu mỗi khoa lâm sàng ít nhất năm bệnh thường gặp.

Cung cấp và hiểu thông tin

Số người được kiểm tra có bằng chứng được giải thích và nhắc lại đúng nội dung cốt lõi / tổng người được kiểm tra. Đây là chỉ số nội bộ đề xuất, không có ngưỡng phần trăm riêng trong A4.1.

Trước đo phải khóa định nghĩa, kỳ, mẫu số và cách chọn đối tượng. Mẫu số bằng 0 ghi không tính được; thiếu dữ liệu ghi chưa xác minh. Không làm tròn dưới ngưỡng thành đạt hoặc suy rộng một mẫu nhỏ thành toàn bộ bệnh viện.

6 BM01 Ghi nhận cung cấp thông tin

Mã đề xuất A41 BM01.

Mã đợt, ngày giờ, người giải thích và người nhận .....

Người ghi và đơn vị .....

Nội dung và lựa chọn	Câu hỏi của người bệnh	Giải đáp và quyết định	Xác nhận phù hợp

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

6 BM02 Khung phiếu tóm tắt điều trị theo bệnh

Mã đề xuất A41 BM02.

Tên bệnh, khoa, hướng dẫn nguồn đã duyệt, mã phiên bản và phê duyệt .....

Người ghi và đơn vị .....

Việc chính và mục đích	Mốc dự kiến cá thể	Đã thực hiện để tự đánh dấu	Cần hỏi nhân viên

Hướng dẫn cá thể về thuốc theo đơn, dinh dưỡng, vận động, dấu hiệu cần báo ngay và kế hoạch ra viện: .....
.....

Đây là khung để biên soạn cho một bệnh cụ thể; chưa phải phiếu được phép cấp người bệnh. Bác sĩ và khoa hoàn thiện từ hướng dẫn điều trị đã duyệt; không tự điền phác đồ chung cho mọi người bệnh. Người bệnh chỉ tự đánh dấu theo dõi, không tự chỉ định xét nghiệm hoặc điều chỉnh thuốc.

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

6 BM03 Quản lý phiếu theo từng khoa

Mã đề xuất A41 BM03.

Kỳ, danh sách khoa đầy đủ và đầu mối rà soát .....

Người ghi và đơn vị .....

Khoa và bệnh thường gặp	Mã phiếu, nguồn	Phê duyệt, cập nhật	Cấp phát và tư vấn

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

6 BM04 Yêu cầu thông tin và đánh giá hiệu quả

Mã đề xuất A41 BM04.

Kỳ, phạm vi, người phụ trách; không ghi dữ liệu giả .....

Người ghi và đơn vị .....

Yêu cầu hoặc vấn đề	Bằng chứng, kết quả	Cải tiến và người phụ trách	Thời hạn, đo lại

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

7 Danh mục minh chứng và tự đánh giá

Nhóm	Hồ sơ cần tập hợp	Mã và vị trí
MC01	Quy định, quyết định phân công, nguồn lực và phê duyệt.	
MC02	Hồ sơ phổ biến, đào tạo, kiểm tra thực hành và học bù.	
MC03	Biểu mẫu đã thực hiện, dữ liệu nguồn, quan sát và phỏng vấn.	
MC04	Chỉ số, báo cáo, phản hồi, cải tiến và đo lại.	
MC05	Hồ sơ phản ánh, sự cố và xác minh tình trạng mức 1.	

Kỳ đánh giá và phạm vi .....

Tình trạng mức 1 và bằng chứng xác minh .....

Mức đề xuất sau kiểm tra tích lũy .....

Khoảng thiếu và người chịu trách nhiệm .....

Người lập và người kiểm tra .....

Có bộ hồ sơ không đồng nghĩa đạt tiêu chí. Phải kiểm tra hoạt động tại hiện trường và đối chiếu dữ liệu nguồn; các trường hợp chưa xác minh giữ nguyên trạng thái chưa xác minh.

Phụ lục tự đánh giá tiểu mục 1 đến 12

Kỳ và người kiểm tra .....

Mục	Thực trạng hoặc mức đáp ứng	Mã minh chứng	Việc cần bổ sung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Mục 1 ghi có/không tình trạng bất lợi. Các mục khác ghi đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh. Trường hợp không áp dụng chỉ sử dụng khi hướng dẫn cho phép và có căn cứ. Người kiểm tra: .....

Phụ lục tự đánh giá tiểu mục 13 đến 20

Kỳ và người kiểm tra .....

Mục	Thực trạng hoặc mức đáp ứng	Mã minh chứng	Việc cần bổ sung
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Mục 1 ghi có/không tình trạng bất lợi. Các mục khác ghi đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh. Trường hợp không áp dụng chỉ sử dụng khi hướng dẫn cho phép và có căn cứ. Người kiểm tra: .....

8 Nguồn và kiểm tra trước ban hành

[1] Bộ Y tế. QĐ6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, tiêu chí A4.1, trang in 33–34.

https://trungtamytehuyentanyen.vn/public/uploads/files/quyet-djinh-6858qdj-byt-nam-2016-ve-bo-tieu-chi-chAt-luong-benh-vien-viet-nam-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh_5faed01464.pdf

[2] Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15, Điều 9–13 và quyền tiếp cận hồ sơ theo Điều 69.

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-15-2023-qh15-kham-benh-chua-benh-119231127164453959.htm

Ngày đối chiếu nguồn 16/10/2026. Bộ phận phụ trách xác nhận hướng dẫn kiểm tra áp dụng cho kỳ đánh giá thực tế; đối chiếu thêm TT35/2024/TT-BYT về tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với bệnh viện khi lập hồ sơ chất lượng chung.

□ Điền số văn bản, phiên bản, ngày áp dụng và người có thẩm quyền.

□ Chốt đầu mối, nguồn lực, lịch triển khai và mục tiêu từ thực trạng.

□ Rà soát nội dung, biểu mẫu và quy định chuyên môn, pháp lý liên quan.

□ Phê duyệt, phổ biến và kiểm tra việc áp dụng.

□ Bổ sung dữ liệu và minh chứng thật trước khi ký kết luận mức đạt.